Complexo Terapêutico Para o Cuidado e a Recuperação da Dependência Alcoólica

1. Delimitação do Tema e do Fenômeno

O trabalho delimita-se no campo da Arquitetura para Saúde Comportamental, investigando a relação entre a infraestrutura física dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD III) e a reabilitação/recuperação de pessoas com Transtorno por Uso de Álcool (TUA). O elemento central analisa a maneira que o ambiente construído pode superar as limitações de edificações hospitalares ou que não estão adaptadas adequadamente, que funcionando historicamente por uma lógica de contenção, e consequentemente elevando o estresse e o estigma do usuário (EKHAESE; EZEORA, 2024; GOULART; ONO, 2021). O problema investigado está principalmente na escassez de diretrizes arquitetônicos baseados em evidências que articulem o atendimento público 24 horas e o acolhimento noturno da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) às necessidades psicossociais, sensoriais e cognitivas da pessoa com dependência alcoólica em recuperação (BRASIL, 2012; NASCIMENTO et al., 2022). Delimita-se o projeto de um Complexo Terapêutico Para o Cuidado e a Recuperação da Dependência Alcoólica.

2. Justificativa

A importância social e urbana do tema está relacionada aos dados sobre o consumo de álcool no Brasil, apresentados pelo Vigitel (BRASIL, 2023a), que mostram o crescimento do consumo abusivo de álcool no Brasil de 15,7% para 20,8%, com forte alta entre mulheres (7,8% para 15,2%). Segundo pesquisas de tendência temporal conduzidas por Malta et al. (2025), as metas globais de redução do alcoolismo para 2030 não serão atingidas no país, podendo gerar severas vulnerabilidades socioespaciais e rupturas familiares. Inserir um Complexo Terapêutico territorializado na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), ligado às diretrizes do CAPS AD III e da Portaria nº 336/2002 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002, 2004), é urgente para oferecer acolhimento 24 horas e desconstruir o estigma urbano do uso prejudicial de álcool.

A contribuição do trabalho está relacionada aos problemas identificados por Goulart e Ono (2021) em CAPS AD III, onde muitos serviços funcionam em edifícios adaptados, com ambientes pouco acolhedores e limitações de conforto. Este trabalho contribui ao propor parâmetros projetuais baseados em evidências (EBD) que integram unidades de acolhimento inspiradas no ambiente doméstico (JAFARI et al., 2025), neuroarquitetura (SILVA; PEREIRA; RODRIGUES, 2022), biofilia e jardins de cura (BAGNATI; FEDRIZZI, 2021) para o manejo da ansiedade e da fissura (vontade intensa de consumir álcool). A proposta avança ao equilibrar a supervisão clínica não invasiva com a autonomia ambiental, a privacidade e a convivência comunitária, sintetizando uma resposta arquitetônica humanizada às necessidades psicossociais do paciente em reabilitação (EKHAESE; EZEORA, 2024).

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver o projeto arquitetônico de um Complexo Terapêutico Para o Cuidado e a Recuperação da Dependência Alcoólica.

3.2 Objetivos Específicos

- Projetar unidades de acolhimento inspiradas no ambiente doméstico, concedendo ao usuário autonomia sobre parâmetros microambientais de iluminação, temperatura e privacidade;
- Estruturar uma setorização funcional baseada em anéis de privacidade, garantindo supervisão clínica não invasiva e clareza de orientação espacial;
- Incorporar estratégias de neuroarquitetura, biofilia e jardins de cura para o conforto sensorial e alívio de estressores psicológicos durante a desintoxicação;
- Propor espaços de convivência, oficinas e lazer abertos à família e à comunidade, estimulando o suporte social e a reintegração urbana.

4. Recorte da Revisão de Literatura

A discussão sobre a arquitetura em espaços de tratamento para pessoas com dependência alcoólica envolve tanto as condições de atendimento oferecidas pelos serviços de saúde quanto as características dos ambientes em que os pacientes permanecem. No Brasil, os CAPS AD III fazem parte da rede pública de saúde mental e oferecem atendimento contínuo e acolhimento noturno, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002, 2004, 2012). Mesmo com essa estrutura de atendimento, ainda existem dificuldades no funcionamento desses

serviços. Nascimento et al. (2022) e Souza et al. (2022) discutem questões relacionadas ao atendimento e ao manejo de situações de crise, enquanto Goulart e Ono (2021) chamam a atenção para as condições físicas das unidades, muitas vezes instaladas em imóveis adaptados. Essa realidade também precisa ser considerada diante dos dados sobre o consumo abusivo de álcool apresentados por Malta et al. (2025) e pelo Vigitel (BRASIL, 2023a), que reforçam a importância dos serviços destinados a essa população.

As condições dos espaços de tratamento também aparecem em estudos que investigam como a arquitetura pode atender às necessidades dos pacientes. Ekhaese e Ezeora (2024) discutem a relação entre o bem-estar psicossocial e os elementos arquitetônicos presentes em centros de reabilitação. Questões como privacidade, segurança e autonomia também são abordadas por Jafari et al. (2025), que destacam sua importância nos ambientes residenciais de tratamento. No campo da neuroarquitetura, Silva, Pereira e Rodrigues (2022) estudam a influência dos espaços sobre as pessoas, enquanto Bagnati e Fedrizzi (2021) abordam o uso de jardins de cura em ambientes de recuperação. Esses estudos ajudam a compreender que o atendimento não depende apenas dos procedimentos clínicos, mas também das condições oferecidas pelo ambiente. Para o desenvolvimento deste trabalho, essa discussão serve de base para pensar um complexo voltado ao cuidado de pessoas com Transtorno por Uso de Álcool (TUA), no qual a segurança e o acompanhamento dos pacientes sejam conciliados com espaços de convivência, privacidade e autonomia.

5. Conceitos Estruturantes da Proposta

A proposta para o Complexo Terapêutico fundamenta-se na articulação de quatro conceitos estruturantes encadeados:

5.1 Arquitetura Terapêutica e Projeto Baseado em Evidências (EBD): Considera que o espaço físico pode contribuir para o tratamento da dependência alcoólica e para o bem-estar dos pacientes. Estudos de Ekhaese e Ezeora (2024) e Jafari et al. (2025) mostram a importância de pensar os ambientes a partir das necessidades de quem os utiliza, levando em conta aspectos como segurança, autonomia, dignidade e convivência social. Com base nessas pesquisas, o projeto busca definir soluções arquitetônicas que favoreçam o acolhimento e ajudem a reduzir o estresse e a ansiedade durante o processo de recuperação.

5.2 Unidades de Acolhimento Inspiradas no Ambiente Doméstico: Com base nos estudos de Jafari et al. (2025) e nas avaliações de Goulart e Ono (2021), a proposta

busca criar ambientes de acolhimento que se distanciem da aparência fria dos espaços hospitalares. Para isso, considera a criação de unidades residenciais para o acolhimento e a possibilidade de os próprios pacientes terem maior controle sobre o ambiente em que permanecem, podendo ajustar a iluminação, a ventilação e a temperatura do quarto, além de personalizar o espaço. Essas escolhas podem contribuir para que os usuários se sintam mais confortáveis e tenham maior participação na rotina de tratamento, respeitando suas necessidades individuais durante a recuperação do Transtorno por Uso de Álcool (TUA).

5.3 Neuroarquitetura, Biofilia e Jardins de Cura: Considera como os ambientes construídos e o contato com a natureza podem influenciar o bem-estar dos pacientes durante o tratamento. Silva, Pereira e Rodrigues (2022) abordam a relação entre a arquitetura e as respostas das pessoas aos espaços, enquanto Bagnati e Fedrizzi (2021) destacam a contribuição dos jardins terapêuticos para a recuperação. No projeto, esses aspectos podem ser trabalhados por meio da iluminação natural, da ventilação cruzada, do uso de materiais com diferentes texturas e da presença de áreas verdes. A intenção é criar espaços mais agradáveis, que favoreçam o relaxamento e ofereçam contato com a natureza durante o processo de desintoxicação, contribuindo para o bem-estar físico e emocional dos pacientes.

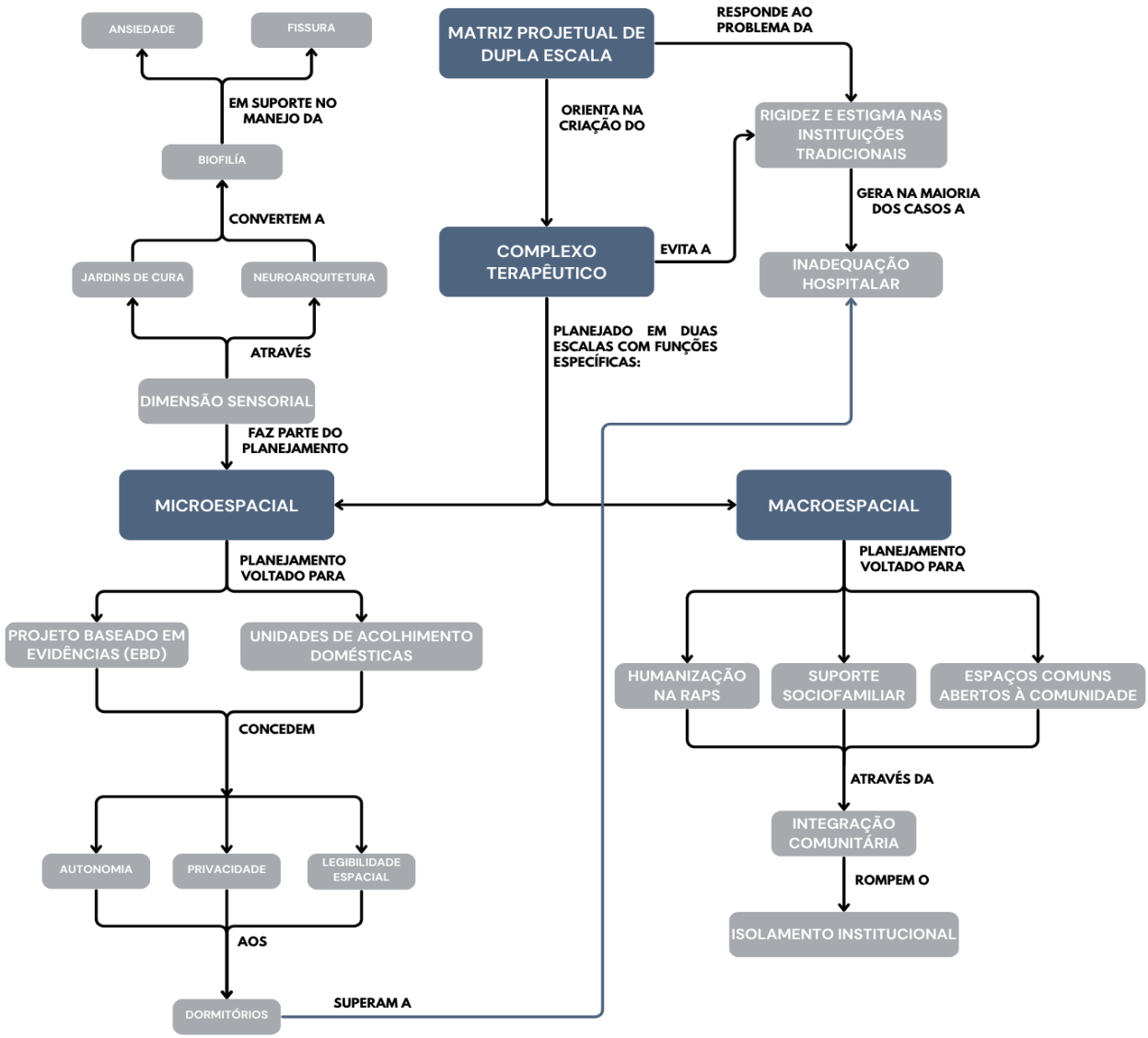
5.4 Humanização Terapêutica na RAPS e Suporte Sociofamiliar: Considera a importância da convivência social e da participação da família durante a recuperação de pessoas com Transtorno por Uso de Álcool. As diretrizes do Ministério da Saúde valorizam o cuidado em liberdade e a reintegração social dos usuários. Nesse sentido, estudos de Souza et al. (2022) e Jafari et al. (2025) contribuem para pensar ambientes que favoreçam o contato entre pacientes, familiares e comunidade. A proposta inclui espaços como oficinas, academias, refeitórios e áreas de convivência, que podem estimular a interação e ajudar na reconstrução dos vínculos sociais. Dessa forma, a arquitetura busca aproximar o complexo da comunidade, evitando que o local seja visto apenas como um espaço de tratamento isolado da cidade.

A articulação desses conceitos demonstra que a cura não vem de elementos isolados, mas da coerência de um sistema integrado: o EBD (Estudos Baseados em Evidências) estabelece o método científico; as unidades domésticas qualificam a experiência individual; a neuroarquitetura e os jardins promovem a restauração sensorial; e a humanização na RAPS assegura o pertencimento social.

6. Síntese Interpretativa

A síntese dos conceitos serve de guia central para a investigação do tema ao estabelecer uma matriz projetual de dupla escala (micro e macroespacial) que responde ao problema da rigidez e do estigma nas instituições tradicionais (EKHAESE; EZEORA, 2024; GOULART; ONO, 2021) visando um complexo terapêutico eficiente. No "microespacial", o Projeto Baseado em Evidências (EBD) e as unidades de acolhimento domésticas superam a inadequação hospitalar ao concederem autonomia, privacidade e legibilidade espacial aos dormitórios (JAFARI et al., 2025). Na dimensão sensorial, a neuroarquitetura e os jardins de cura convertem a biofilia em suporte no manejo da ansiedade e da fissura (BAGNATI; FEDRIZZI, 2021; SILVA; PEREIRA; RODRIGUES, 2022). No "macroespacial", a humanização na RAPS e o suporte sociofamiliar rompem o isolamento institucional ao integrar espaços comuns abertos à comunidade (BRASIL, 2004; SOUZA et al., 2022).

7. Diagrama Conceitual



8. Referências (Foi utilizado I.A para auxílio na organização e revisão das fontes)

- BAGNATI, M. B.; FEDRIZZI, B. M. Jardim de Cura: um recurso para os espaços abertos de instituição especializada na reabilitação de dependentes químicos. Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente, v. 6, n. 3, p. 97–110, set. 2021.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2002.
- BRASIL. Ministério da Saúde. A Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas. 2\. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2004.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 130, de 26 de janeiro de 2012. Redefine o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas 24h (CAPS AD III). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2006-2023: tabagismo e consumo abusivo de álcool. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023a.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023b.
- EKHAESE, Eghosa; EZEORA, Ifeanyi. Psychosocial well-being needs of people with alcohol/drug use disorder and therapeutic architectural solutions in rehabilitation centre, Nigeria: a cross-sectional study. F1000Research, v. 12, n. 705, p. 1–28, 2024\. DOI: 10.12688/f1000research.125151.2.
- GOULART, Fernanda; ONO, Rosaria. Avaliação Pós-Ocupação em Centros de Atenção Psicossocial: identificando as demandas e especificidades desta tipologia arquitetônica. Gestão & Tecnologia de Projetos, v. 16, n. 4, p. 115–132, 2021.
- JAFARI, Nazli et al. Design strategies to promote better experiences for substance abuse patients in rehabilitation. HERD: Health Environments Research & Design Journal, v. 18, n. 4, p. 111–124, 2025\. DOI: 10.1177/19375867251346497.
- MALTA, Deborah Carvalho et al. Tendência temporal do consumo abusivo de bebidas alcoólicas e suas projeções para 2030 nas capitais brasileiras. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 28, e250057, p. 1–14, 2025\. DOI: 10.1590/1980-549720250057.2.
- NASCIMENTO, Ana Carolina Peixoto do et al. O que se entende por acolhimento noturno pela equipe do CAPS AD III de Palmas/TO: relato de experiência. Revista Humanidades e Inovação, v. 9, n. 11, p. 153–165, 2022.
- SILVA, Kátia das Dores Moreira da; PEREIRA, Tatiane Fernandes Matias; RODRIGUES, Fábio Ramalho. Arquitetura como aparato no tratamento da dependência química: uma

análise a partir de edificações destinadas ao tratamento. Ágora: A Revista Científica do UNIFASAR, v. 4, n. 1, p. 1–18, dez. 2022.

- SOUZA, Fernanda Silveira de et al. Construção de fluxos de atenção em CAPS AD para qualificação de processos de cuidado. Cadernos Brasileiros de Saúde Mental, v. 14, n. 40, p. 53–72, 2022.